

방광염 — 항생제 전에 소변검사, 그리고 끝까지

방광염은 방광에 세균이 들어와 생기는 흔한 감염으로, 소변 볼 때 따갑거나 갑자기 자주 마려운 증상이 대표적입니다. 검사와 복용 순서를 지키는 것이 정확한 진단과 재발 예방의 핵심입니다.

치료의 원칙 3가지

- 1 항생제를 먹기 전에 소변검사를 받으세요 — 약을 먹은 뒤에는 검사가 부정확할 수 있습니다. 필요하면 배양검사도 함께 하고, 결과가 나오면 더 잘 듣는 약으로 바꿀 수 있습니다.
- 2 처방받은 기간(예: 5일) 끝까지 드세요 — 증상이 좋아져도 임의로 중단하지 마세요. 약마다 정해진 기간이 다르므로, 처방받은 대로 끝까지 복용하는 것이 핵심입니다.
- 3 물을 많이 마시고 소변을 참지 마세요 — 수분을 충분히 섭취하고, 소변이 마려울 때 습관적으로 오래 참지 않는 것이 회복과 재발 예방에 도움이 됩니다.

이런 경우는 구분이 필요합니다

신우신염 의심 · 바로 오세요

옆구리 통증, 열·오한이 있으면 신우신염일 수 있습니다. 바로 오세요.

메스꺼움·구토가 함께 있는 경우

방광염 약을 먹는데도 증상이 나아지지 않거나 오히려 나빠지는 경우

몹시 아프거나 상태가 빠르게 나빠지는 경우

오래된 빈뇨는 다를 수 있음

오래된 빈뇨는 염증이 아니라 과민성 방광일 수 있습니다.

새로 갑자기 생긴 배뇨통·빈뇨는 방광염 쪽에 가깝습니다.

오래 지속된 빈뇨만으로는 급성 방광염으로 단정하지 않습니다.

구분이 애매하면 진료 시 함께 확인하세요.

흔한 오해 바로잡기

“소변이 잦으면 콩팥이 나쁜 것” — 아닙니다. 빈뇨는 대개 방광의 문제이고, 콩팥까지 번진 경우는 열·옆구리 통증으로 나타납니다.

“주사 항생제 한 방이면 된다” — 아닙니다. 방광염의 기본 치료는 처방받은 기간 동안 먹는 항생제를 다 복용하는 것입니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 국내 요로감염 항생제 사용지침 2018 · IDSA/ESCMID 요로감염 치료지침 2010 · EAU 요로감염 지침 2026 · AUA/SUFU 과민성 방광 지침 2024

본 자료는 일반적인 성인 여성의 단순 방광염 안내입니다. 임신, 재발성 감염, 남성의 요로감염, 신우신염 의심 상황은 검사와 치료 방침이 달라질 수 있으니 진료 시 확인하세요.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/screening/cystitis-uti/